



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رسميه احمد فراج محمد
 المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : مصر الجديد
 رقم البطاقة : 25911020102826 رقم التليفون : 01098978337
 العمر (تاريخ الميلاد) : 02-11-1959 المهنة : ربه منزل
 العنوان : 1 ح جمعه امام عطيه
 تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
 الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
 نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
 الإخصائي الاجتماعي التوقيع: (-----)
 المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
 الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
 الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
 أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
 وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
 كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
 تعتمد صحة البيانات المرفقة
 رئيس اللجنة ومدير
 المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
 بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 قسم :
 نفقات :
 جهة العلاج :
 ملاحظات :

ختم
 شعار الجمهورية

مدير عام
 مديرية الشؤون الصحية

رئيس
 المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رسميه احمد فراخ محمد National ID: 25911020102826	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

MDT FORM No 1 2 / 2022

අයදුම්කරු	එම්. ඩබ්ලිව්. ආර්ථිකරත්න	MRN	0000000000
වයස	60	ID	0000000000
Menopausal status	postmenopausal	Phone	011 234 5678
PBS SCORE	0	marital status	Married
RAC	Over weight	Family history	None
Co morbidity	DM, HTN, T.B.C.S	REASON OF MDT	

Clinical Data			
T.D.C.H			
CR:	PR:	HER 2:	HER 3:
11	11	11	11
Sonography: Microscopy: lobular.			
Ct Scan: Bone Scan -> Fine NEW CTs -> Fine			

Recommendations: - post-menopausal L. breast Ca. T1N0
- CTs Free, Bone Scan -> Fine
For MDT

MDT OUTCOME & PLAN

Dr L.D.C. (Tambur/End)
POPT Hormone test A.T. S.T. &
2 meta/ 6 month.

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Medication
S.D. H.		D. P. H.		

Patient Name : الأستاذ / رومية احمد فراج محمد
Patient No. : 25911020102826
Path No. : SR-534/22
Sex : Female
Age : 62 Y
Referring Doc :

Request No. : 13000192
Request Date : 26/07/2022
Verification Date : 03/08/2022
Financial Category : جرسات روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast mass

Nature of the specimen:

Slide revision

Gross Examination:

17 blocks (4737/22) + 1 block (3425/22) + 5 slides

Microscopic examination:

1- Tru cut biopsy

• Histological type: Invasive duct carcinoma

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Ductal carcinoma in situ: No

-IPT:

ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8)

PR: Moderate nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 7/8)

Her-2: Weak complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+)

SISH: Both referred slides were not amplified, average HER2 copy number: 2.3.

HER2/CEP17 ratio: 1.3

2-Operation:

• Histological type: Invasive micropapillary carcinoma

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Ductal carcinoma in situ: No

• Lymph node involvement: (9/18) with capsular infiltration

• Resection Margins: Free received margin

• Additional pathologic findings: Excessive lymphocytic infiltration

Diagnosis:

Left breast mass, slide revision:

1- Tru cut biopsy:

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 28/07/2025 13:28:03

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / ريميه احمد فراج محمد
Patient No. : 25911020102826
Path No. : SR-534/22
Sex : Female
Age : 62 Y
Referring Doc :

Request No. : 13000192
Request Date : 26/07/2022
Verification Date : 03/08/2022
Financial Category : نفقة الدولة - جرسات روسي
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Invasive duct carcinoma , grade II
-IPT:
ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 7/8).
HER-2: Equivocal (score 2+).
SISH: Not amplified (both referred slides)
2-Operation:
Invasive micro papillary carcinoma, grade II
Free received margin
LNs:(9/18) with capsular infiltration

Prof. Gamal Abdelatty
Dr. Esraa Magdy

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 28/07/2025 13:28:03

Page 2 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt



Patient Name: Rasmeya Ahmed Farraag Mohamed	Date : 06/04/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 2823/2022	

Total DLP (mGy.cm) 669

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Reported case of operated left breast cancer

I Chest:

- Left breast skin thickening (11 mm). left axillary scarring with no sizable ipsilateral enlarged axillary lymph nodes.
- Left upper and lingular fine subpleural reticulations....post radiotehrapy sequel.
- Left fissural based nodule meauring 6 mm.
- Few prominent subcentimetric mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with left hepatic lobe segment Iva enhancing focal lesion measuring 12 X 8 mm which become inconspicuous in delayed phases.
- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Rasmeya Ahmed Farraag Mohamed	Date : 06/04/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 2823/2022	

- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Bone window showing:
 - Dorsal spondylosis.
 - Grade I lytic antrolithesis of L5 over S1 vertebrae.
 - No worrisome lytic or sclerotic bony lesions.

Opinion:

Reported case of breast carcinoma showing:

- Tiny left pulmonary nodule mostly non-specific for follow up.
- Left hepatic lobe focal lesion likely hemangioma for close follow up.

Dr.Shairnaa Megahed,MSc

Signature Dr. Mohamed Mohsen

06/04/2024 01:41